

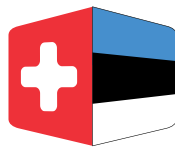
EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMM
ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME



EVAKUATSIOONIJUHI KOOLITUSMATERJAL

Koolitusmaterjal Eesti ööpäevaringselt
kasutatavatele haiglatele ja hooldekodudele

2013



EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMM
ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME



t u l e t a r k
t a r g e m k u i t u l i

Käesolev koolitusmaterjal on koostatud Päästeameti
poolt elluviidava Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti
„Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine - tuleohutuse suurendamine
Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeesutustes“ raames.

Koostanud: OÜ Tuletark
OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

KOOLITUSMATERJALI KOOSSEIS

1. Objekti evakuatsioonijuhi koolitusprogramm	4
2. Kriisipsühholoogia alused	7
3. Ohuolukorras käitumine	17

OBJEKTI EVAKUATSIOONIJUHI KOOLITUSPROGRAMM

Maht	6 akadeemilist tundi* (edaspidi tund)
Koolituse kestus	1 päev
Õppevormid	Kontaktundide maht: 3 tundi Prakiline õpe: 3 tundi
Õppekeel	Eesti keel
Koolitaja kvalifikatsioon	Tuleohutuskonsultant

*lisaks peab läbima töötaja koolitusprogrammi mahus 3 tundi teoreetilist + 5 tundi praktilist

1. ÕPPE EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED

Objekti evakuatsioonijuhi koolitusprogrammi eesmärgiks on:

- luua tingimused, et haigla ja hoolekandeesutuste personaliliikmed oleksid ohutusalaselt koolitatud;
- toetada koolitatute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud haiglate ja hoolekandeesutuste ohutusalase võimekuse tagamiseks.

Objekti evakuatsioonijuhi koolitusprogrammi edukal lõpetamisel koolitatu:

- teab ja järgib objekti tulekahju korral tegutsemise plaani;
- oskab hinnata ohuolukorda, võtta vastu otsuseid ja reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel/jalahendamisel vastavalt objekti tuleohutusstrateegiale ning protseduuri reeglitele;
- oskab teha koostööd operatiivjõududega.

2. ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Koolitusele kandideeriv isik peab:

- olema objekti töötaja ning varasemalt läbinud töötaja koolituse;
- olema tutvunud objekti tulekahju korral tegutsemise plaaniga;
- soovitavalt omama töökogemust objektil vähemalt 6 kuud.

3. ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppes tuleb läbida teoreetiline ning praktiline osa, mis võivad toimuda erinevatel aegadel, kuid koolituse edukaks lõpetamiseks on kohustuslik mõlema osa läbimine.

Õpe lõpeb evakuatsiooniõppuse või -harjutuse sooritamise, mille käigus hinnatakse koolitatava oskusi ohuolukordade tuvastamisel, nendele reageerimisel ning evakuatsiooniprotsessi juhtimisel.

Lõpetamisel väljastatakse koolituse läbimist tõendav kaart.

4. KOOLITUSPROGRAMMI ÕPPEMOODULITE ÜLESEHITUSE KIRJELDUS

Õppemoodul, alateemad	Tundide maht
1. OHUOLUKORRAS KÄITUMINE	3 tundi kontakt- või e-õpet 3 tundi praktilist õpet
Alateemad: kriisipsühholoogia alused; ohuolukorrast teavitamine (patsientide, klientide, töötajate); tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu; koostöö operatiivteenistustega (k.a edastatava teabe sisu); inimeste päästmine ohustatud alast; ohutu evakuatsiooni põhimõtted; evakuatsiooni korraldamine. Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö või ülesannete lahendamine, demonstratsioon. Õpiväljund: oskab ohte hinnata, võtta vastu otsuseid ja reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel ja lahendamisel vastavalt objekti evakuatsioonistrateegiale ja protseduureeglitele. Õppematerjalid: loengukonspekt, praktilised ülesanded, videod.	

OHUOLUKORRAS KÄITUMINE

Loengukonspekt
(Evakuatsioonijuht)

SISUKORD

SISSEJUHATUS	10
1. KRIISIPSÜHHOLOOGIA ALUSED	11
1.1 Kriis	11
1.2 Traumaatiline kriis	12
1.3 Kriisireaktsiooni tugevust mõjutavad tegurid	13
1.4 Käitumine kriitilises olukorras	13
1.5 Kuidas käituda kriisis inimesega	15
1.1.1 Tähelepanu kõrvalejuhtimine	15
1.1.2 Katkestamine	15
1.1.3 Sisseimbumine	15
1.1.4 Üldine käitumine	16
2. OHUOLUKORRAS KÄITUMINE	17
2.1 Hoonesisene teavitamine	17
2.2 Häirekeskuse teavitamine numbril 112	19
2.3 Evakuatsioon	20
2.4 Evakuatsiooni algus	21
2.5 Evakuatsiooni põhimõtted	22
2.6 Eripärad klientide/patsientide evakueerimisel	24
2.7 Evakuatsiooni takistavad tegurid	24
2.8 Evakuatsioonijuhi ülesanded	24
2.9 Kogunemiskoht ja käitumine kogunemiskohas	25
2.10 Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis	25
3. PRAKTILINE HARJUTUS	26
4. KAASUS/ ÜLESANNE	27
4.2 Ülesanne 2	28
4.3 Ülesanne 3	31
4.4 Ülesanne 4	32
KOKKUVÕTE	33
KASUTATUD ALLIKAD	34

JOONISED JA TABELID

Joonis 1. Üheastmeline evakuatsioon	22
Joonis 2. Horisontaalne evakuatsioon	23

SISSEJUHATUS

Käesolev loengukonspekt on suunatud asutuse evakuatsioonijuhile või –juhtidele, kelle ülesanded tulekahju korral on teised, kui tavapäraselt töötajal. Evakuatsioonijuht peab tagama sujuva ja ohutu evakuatsiooni. Selleks on aga oluline mõista enda rolli evakuatsioonijuhina.

Samuti on oluline, et evakuatsioonijuht tunneks kriisipsühholoogia aluseid, et osata käituda olukorras, kus evakuatsioonijuhina antavad korraldused ei tundu toimivat.

Töötaja ja evakuatsioonijuhil vajalik teadmiste tase on suures osas sama, mis kajastub ka materjalis, kuid oluline on kogu õppeprotsessi ajal keskenduda tema erisustele ja läheneda evakuatsioonijuhil rollile võrdluses töötaja rolliga.

Evakuatsioonijuhil roll on vastutusrikas, seetõttu tuleb sellesse suhtuda tõsiselt. Samavõrd oluline, nagu fakt, et evakuatsioonijuht peab jääma evakuatsiooni ajal kindlaks ja tundma kriisipsühholoogia põhimõtteid on fakt, et selleks tuleb valida ka vastav inimene, kes oma isiksuseomadustelt sobib. Tihti see asjaolu unustatakse, mille tulemuseks võib olla evakuatsioonijuht, kes vajab ise juhtimist.

1. KRIISIPSÜHHOLOGIA ALUSED

Tihti võtame tulekahjuolukorrast ning sealhulgas seda juhtiva inimese käitumisest rääkides justkui iseenesest või kergelt sõnu „Anna selgeid ja konkreetseid korraldusi“, „Räägi valjult ja selgelt“, „Suuna inimesed hoonest välja“ jne, unustades mitmel juhul ära sündmuse erakordsuse. Kui tihti me mõtleme sealjuures, et kas need laused ka tegelikkuses toimivad?

Tegemist on ju sündmusega, mis võib areneda väga ettearvamatult, samuti võivad käituda selles inimesed – ettearvamatult. Tegemist on paljude jaoks kriisiga.

Evakuatsiooni juhtiv isik peab seda teadma ja sellega arvestama, et on neid, kes võivad muutuda agressiivseks, hüsteeriliseks või sootuks tarduda „soolasambaiks“ – ka need, kes tavaolukorras tunduvad nn „maailma kõige tugevama psüühikaga inimestena“.

Mõistes kriisi olemust ning inimeste võimalikke erinevaid reaktsioone sellele, ning tundes ühtlasi mõningaid tehnikaid kriisisituatsioonis tegutsemiseks ja kriisis inimesega suhtlemiseks, on võimalik, et evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist juhtiv isik suudab viia ka reaalselt ellu oma ülesandeid, mis on talle pandud kas ametikohast tulenevalt ja/või asutuse tulekahju korral tegutsemise plaaniga.

1.1 Kriis

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.



Sõna kriis tuleneb kreeka keelest ning tähendab muutust, ohtu, pööret, otsustust, lahutust, eraldamist, lahutamist, võimalust (kr.k *krisis*). Psüühiline kriis on inimese psüühika loomulik reaktsioon äkitselt muutunud olukorrale. Seega on kriis otsekui puhver, mis hoiab ja kaitseb inimest kui tervikut selle läbi, et juhtunu tähendus jõuab inimeseni järkjärgult. Kriisireaktsioon kaitseb isiksuse terviklikkust, lubamata meil juhtunu mõjul „katki minna“, ning lastes meil uue olukorraga tasapisi kohaneda (Ugur 1999).

Kriisid on muut(u)mist nõudvad, liikumapanevad jõud. Kriiside läbi on võimalik kasvada ja areneda. Muutused võivad olla välised, (praktilised, käitumuslikud) või sisemised (väärtushinnangud). Kriisid on lahutamatu osa inimest. Tervet elu võib vaadeldagi psüühiliste kriiside jadana. Samas ei soovi keegi meist kriisi sattuda, kuna see toob kaasa kannatusi ja muret. Mõnikord võivad need kannatused olla niivõrd rasked, et ainsaks lahenduseks võib tunduda olevat suitsiid või põgenemine haigusesse. Kriis on nagu hargnev rada, kus on võimalik valida tervise ja haiguse vahel (Orav 1998).

Et kriisist aru saada, on oluline teada, mis on põhjustanud kriisi vallandumise.

Eristatakse arengu- ja situatsiooni (traumaatilisi) kriise, tulekahjuolukorras tekkivat võib liigitada just viimasesse kategooriasse.¹

1

Karmel Tall, E-kursuse „Kriisipsühholoogia (P2AV.TK.475)“ materjalid, Tartu Ülikool, 2012

1.2 Traumaatiline kriis

Traumaatilistest kriisidest ei oma kõik inimesed kogemusi, need ei kuulu tingimatult inimese loomulikku elukaarde. Põhimõtteliselt pole võimalik traumaatiliseks kriisiks ette valmistada. Traumaatiline kriis on põhjustatud äkilisest, ootamatust ja ebatavaliselt tugevast sündmusest, mis võiks põhjustada märgatavaid kannatusi ükskõik kellele.²

Mis on trauma?

Trauma on igasugune kogemus, mis kujutab ohtu inimese tervisele ja heaolule. Trauma viitab inimese ellujäämise põhireeglite rikkumisele: Neid reegleid rikuvad sageli mitmed sündmused, mis viitavad sellele, et maailm on kontrollitamatu ja ennustamatu (nt. raske haigus, puue, füüsiline või seksuaalne vägivald, sotsiaalne alandamine, töö/teenistuse kaotus, lahutus ja lahusolek, raske kaotus, tegelik või võimalik õnnetusjuhtum jt.) (Brewin, Dalgleish, & Joseph, 1996). Ajaliselt võib traumad jagada kahte tüüpi: ühekordne episood ja korduv trauma.³

Traumaatiline kriis on kahtlemata enamiku jaoks ka tulekahju. Vaid väga vähesed inimesed on isiklikult kogenud tulekahju, rääkimata sellest, et olnud põlevas hoones, kus ta ei tea, kui suur on oht, millal see temani jõuab, kas ta pääseb põlevast hoonest jne.

Traumaatilist kriisi võivad põhjustada erinevad sündmused ja nähtused, mida liigitatakse⁴:

1. Isiksusele olulise objekti kaotus, näiteks

- lähedase inimese surm
- enda või lähedase tõsine haigus

2. Iseseisvuse kaotus

- haiglasse sattumine
- vanglasse sattumine

3. Seksuaalelu ja soojätkamisega seotud probleemid

- viljatus, sellega seotud uuringud ja ravi

4. Häbi põhjustavad olukorrad

- vahelejäätmine väiksema seaduserikkumisega

5. Suured sotsiaalsed ümberkorraldused

- töökoha kadumine või kaotus
- sunnitud elukohavahetus

6. Katastroofid

- loodusõnnetused
- tööstusõnnetused
- liiklusõnnetused
- tulekahjud
- neis õnnetustes osalemine ohvri, süüdlase, päästja või pealtnägijana
- enesetapp või psüühiline haigus lähikonnas
- massikommunikatsiooni vahendusel saadud sekundaarne trauma, mis inimest otseselt ei puuduta.

2 Samas
3 Samas
4 Samas

Traumaatilise kriisi võivad vallandada erinevad sündmused. Mõnikord võivad sündmused kumuleeruda ning konkreetne, vähetähtsana tunduv sündmus võib esile kutsuda ootamatult tugeva reaktsiooni.

1.3 Kriisireaktsiooni tugevust mõjutavad tegurid

Üks ja sama sündmus võib erinevate inimeste juures esile kutsuda väga erineva iseloomu ja tugevusega reaktsiooni. See on seotud inimeste erineva vanuse ja elukogemusega, aga ka mitmete teiste asjaoludega.

Varasem kriisikogemus

Iga kriisiprotsess jätab oma jäljed emotsionaalsesse mällu. Kui inimene on kogenud, et ta jääb suurtes elumuutustes üksi, et teda ei mõisteta või et temast hoitakse eemale, mõjutab see negatiivselt ka iga järgmist kriisi. Samuti võib inimese elus olla varem alanud kriise, mille kulg on valusalt pidurdunud. Sellisel juhul võib ka väike õnnetus esile kutsuda ootamatult tugeva reaktsiooni. Võime öelda, et inimene elab läbi mitut kriisi korraga.

Üldine eluolukord

Kriisireaktsioon on seda pehmem, mida turvalisem on inimese elu õnnetuse hetkel. Kui tema ümber on pere, sõbrad ja lähedased, kui tal ei ole hetkel majanduslikke muresid, kui tal on kindel kodu, emotsionaalselt rahuldavad lähisuhted ja tulevikuperspektiivid ei tekita ebakindlust, on tal olemas suur osa toest, mida traumaatilise kriisiga toimetulekuks vajatakse. Vastupidi, mida üksildasem on inimene, seda rohkem valu võib kriis põhjustada.

Abi kättesaadavus ja harjumuspärasus

Paljud meist elavad lootusega ise toime tulla. Kui varasem abiotsimine ei ole tulemust andnud, võidakse sellest lausa loobuda. Psühhosotsiaalsel tuge on linnas tunduvalt lihtsam leida kui maal, samas on aga suhtes naabrite vahel külas tugevamad. Kui inimene on harjunud oma tunnetest, sh murest ja valust rääkima, on tal ka kriisiprotsessi käigus kergem abi otsida. Kui inimene saab kriisis olles tõhusat abi, annab see talle olulist kogemuse ka järgmiste kriisiolukordade jaoks. Ta oskab ja julgeb abi otsida.⁵

1.4 Käitumine kriitilises olukorras

Otsesesse ohtu või kiiret reageerimist nõudvasse olukorda sattudes käituvad inimesed erinevalt. Mõned säilitavad rahu ja külma närvi, suudavad olukorda kainelt hinnata ning tulemusrikkalt ja õigesti tegutseda. Nad suudavad ka teisi inimesi aidata ja juhendada. Võib öelda, et nende jaoks saabub šokk alles pärast sündmuskohalt lahkumist. Neid on 10 – 30%.

Paljud ei oska esialgu tegutseda, jäävad nõutuna seisma või, vastupidi tunnevad võitmatut vajadust midagi teha. Nad vajavad abi, et leida õiget tegutsemissuunda ja alluvad hästi autoriteetse inimese juhtimisele. Neid on 50 – 75%.

Mõned langevad masendusse ja otsivad abi. Nad vajavad turvalise täiskasvanu lähedust. Neid on 10 – 25%.

Mõned satuvad paanikasse. Paanikasse sattunud inimene võib tegutseda nii, et paneb täiendavasse ohtu nii enda kui ka teiste elu. Paanikas olevat inimest ei tohi mitte mingil juhul üksi jätta, ta vajab teise inimese pidevat tähelepanu ning võimalikult kiiret ohukoldest väljatoimetamist. Neid on 1 – 3%.

⁵ Karmel Tall, E-kursuse "Kriisipsühholoogia (P2AV.TK.475)" materjalid, Tartu Ülikool, 2012

Šokiseisundis on kõik reaktsioonid loomulikud

Kõige tavalisem reageering ebameeldivale sündmusele on šokk. Selles seisundis on kõik reaktsioonid võimalikud ja loomulikud. Šokk on psüühika enesekaitse liiga tugeva löögi vastu. Teoreetiliselt on see seletatav kui teadvuse eri tasandite vastuolu: inimene teab, mis on juhtunud, kuid ei soovi seda uskuda. See, kuidas me kriitilises olukorras käitume, on peaaegu ettearvamatut. Peame usaldama iseenda ja oma ligimeste psüühikat – see leiab meile kõige säästlikuma tee. Kriisi esimestel hetkedel võetakse vastu palju informatsiooni ja mõeldakse väga kiiresti. Paljud inimesed on öelnud, et nad justkui ei tunnegi midagi. See kaitseb masendusse langemise eest seni, kuni ollakse jõudnud tagasi turvalisse keskkonda.

Mida tunneb ja mõtleb šokis olev inimene

see on nii uskumatu....

võimatu, mis te räägite...

selliseid asju minuga ei juhtu

ma ei taha, lõpetage ära

nagu unes: kohe ärkan üles ja kõik see on olnud lihtsalt paha uni

ma ei arvanud, et võiksin viga saada....

see ei saa olla tõsi..

ei....

ajataju muutub, aeg tundub tormavat või venivat

kogu elu jookseb filmina silme eest läbi: aju otsib sobivat tegevusmudelit varasemast kogemusest tugevad nägemis-, kuulmis- või lõhnaärritajad murravad teadvusse sisse – nii saab aju võimalikult palju informatsiooni, et valida õige käitumisviis mõnel juhul võivad meeled hoopis nürineda, inimene ei näe ega kuule õieti midagi (ega tunne näiteks külma ega valu). See on kaitsereaktsioon, mis hoiab liiga valusate elamuste eest. käitumise aktiivsus muutub: hakatakse palavikuliselt tegutsema või, vastupidi, langetakse apaatiasse võimalikud on ka kehalised reaktsioonid: oksendamine, külmavärinad, soovimatu pissimine vms.

Sellises olukorras on parimaks abiks teise inimese juuresolek ning teadmine, et õnnetuse tagajärgede likvideerimisega tegelevad oma ala tundvad inimesed. Kuna šokk võib kesta päevi, tuleb sel ajal hoolitseda, et inimesel oleks soe ja et ta piisavalt süüa saaks – ise ei suuda ta sageli nende asjade peale mõelda. Šokis olevale inimesele tohib ravimeid anda ainult arst, mitte sõbrad ega kolleegid. Rahustid ja alkohol on üldjuhul vastunäidustatud ning teevad kasu asemel kahju.

Pidage meeles, et tegemist on psüühika enesekaitsereaktsiooniga. See on loomulik ning möödub isenesest.⁶

1.5 Kuidas käituda kriisis inimesega

Raskes psüühilises seisundis olevate inimestega suhtlemine ehk psühhoteraapia. Selleks on erinevaid võtteid või meetodeid.⁷

1.1.1 Tähelepanu kõrvalejuhtimine

Tehnika eesmärgiks on kannatanu tähelepanu kõrvalejuhtimine stresserivast situatsioonist ja selle pööramine mujale. Sama tehnika, mida vanemad kasutavad kui väikelaps tahab telepulti – lapsele pakutakse mingit väga huvitavat asendusobjekti.

- Kasuta mingit stresserivat situatsiooni mitte puudutavat, kuid väga huvitavat jututeemat. Mida sisukam ja mõtlemapanevam teema on, seda parem.
- Ära ütle midagi, mis väljendaks üleolekut, tähelepanu või muretsemise puudumist.
- Kui kannatanu on maha rahunenud, räägi stresserivast situatsioonist fakti-tasandil.

1.1.2 Katkestamine

Kasutatakse juhul kui kannatanu on väga emotsionaalne ja vähese kontaktivõimega.

- Sea ennast kannatanuga samale tasemele (kükita või istu) ja tekita silmside.
- Selge ja rahuliku häälega, kannatanule silma vaadates anna talle tema nime kasutades mingi lihtne käsk: "Mari, tee sügav hingetõmme!".
- Tee paus ja korda seda muutmatul kujul veidi kõvema hääletooniga: "Mari, tee sügav hingetõmme!"
- Jätka käsu kordamist, kasutades täpselt sama sõnastust ja suurenda iga korraga hääle tugevust ning nõudlikkust hääletoonis.
- Tavaliselt täidab kannatanu kolmandal korral käsu.
- Sel momendil madalda oma hääli rahulikule tasemele ja hakka rääkima. Võid anda korralduse teha teine ja kolmas aeglane hingetõmme.
- Kui oled ületanud emotsionaalse tõkke - alusta abistamist.

1.1.3 Sisseimbumine

Kannatanuga kontakteerutakse läbi tema emotsionaalse seisundi.

- Näiteks: alusta oma juttu ärritunud inimesega sama tempo ja tooniga nagu tema. Kui ta räägib valjult – kasuta sama kõva häält. Kui räägib kiiresti – räägi sama kiiresti. Kui ta liigub – liigu sama kiirusega.
- Siis hakka järk-järgult rääkima tasemini, aeglasemalt.
- Kui kannatanu hakkab reageerima rahulikumalt, kontrollitumalt – hakka abistama.
- Tehnika töötab ka vastupidi – passiivselt seisundilt aktiivsema seisundi poole.

1.1.4 Üldine käitumine

Lisaks tasub meeles pidada üldisi põhimõtteid⁸:

KUIDAS AIDATA ŠOKISEISUNDIS INIMEST?

- Hoia käest või õlgadest, inimlik lähedus rahustab ja loob turvalisustunde.
- Anna vaba voli kõnelda ja küsida. Anna küsimustele alati vastuseid, kuid hoidu vägivalda puudutavastest ja õudust äratavatest üksikasjadest.
- Aktsepteeri tema käitumisviisi, talu reaktsioone, olgu see või raev.
- Inimene vajab teiste lähedust, emotsionaalset tuge ja abi sageli isegi söömise, joomise, riietumise juures, kuna ta ei suuda ise nendele tegevustele piisavalt keskenduda.
- Ära noomi teda. ("Mis see siis olgu, võta end kokku", "Saa üle" jne.
- Üliaktiivsuse korral anna šokis inimesele kergeid ülesandeid, lase kellegi saatel ringi liikuda.
- Liikumisvõimetu ja apaatne kata soojalt, sest tal võib esineda vapppekülma.

2. OHUOLUKORRAS KÄITUMINE

2.1 Hoonesisene teavitamine

Tulekahju varaseks avastamiseks ja inimeste ohust teavitamiseks on hoolekandeesutustes ja haiglates automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem (edaspidi ATS). ATS- i töö põhineb lihtsalt öeldes andurite poolt vastuvõetava ohuteate läbi häirekellade kuuldavaks tegemises. ATS-i kaudu ohuteate saamiseks on kaks võimalust: süsteem hakkab tööle automaatselt või vajutab „keegi“ käsiteadustit.

Automaatse rakendumise võib põhjustada tulekahju, kuid tegemist võib olla ka süsteemist või keskkonnast tuleneva valehäirega. Paraku pole nende eristamine ilma kontrollimiseta võimalik. Selleks vaadatakse häire korral esmalt keskseadme tabloolt, millisest avastamispiirkonnast ehk tsoonist häire tuli ja seejärel kontrollitakse kas antud piirkonnas on tulekahju või ei ole. Kontrollimise hetkeks lülitatakse reeglina üldhäire välja ning tulekahju avastamisel taaskäivitatakse see käsiteadustist või keskseadmest olenevalt sellest, kumb neist kontrollijale lähemal asub. Eelkirjeldatu tähendab ühtlasi, et hoonetes, kus selliselt toimitakse, algab evakuatsioon häire teistkordsel käivitumisel.

Käsiteadustist häire käivitamine tähendab reeglina seda, et inimene on tulekahju avastanud. Kui automaatselt edastataval teatel ja käsiteadusti vajutamisega teavitamisel pole võimalik vahet teha, on soovitatav lisaks käsiteadusti vajutamisele kasutada ka füüsilist teavitamist näiteks hääle abil.

Et olla kindel kõigi teavitamises tulekahjust, tuleb määratleda, kes selle eest vastutab ning millised on teavitamise vahendid. Üldine reegel on selline, et ohualas viibijaid teavitab ohualale lähim töötaja või ohu avastaja.

Samas tuleb teavitamises alati kindel olla ning seepärast peab olema kellegi konkreetse kohustus veenduda, kas kõiki (kes tulekahjust teada peaksid saama) on teavitatud ning vajadusel korraldama teavitamise – näiteks evakuatsioonijuht või mõni muu isik. Sõltuvalt sellest, keda teavitatakse, on teavitamise peamisteks vahenditeks sealjuures:

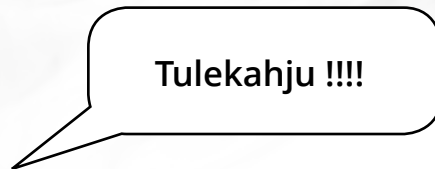
Hoonesisese teavitamise võimalused olenevalt sellest, kuidas tulekahjust teada saadakse ja millised on tehnilised lahendused, võivad üldjuhul olla järgmised:

- teavitab ATS läbi häirekellade või vaikse alarmi automaatselt – tulekahju avastajaks on ATS;
- teavitab ATS läbi tekstiedastussüsteemi automaatselt – tulekahju avastajaks on ATS;
- teavitab inimene vajutades ATS käsiteadustit – tulekahju avastajaks on inimene;
- teavitab inimene oma hääle abil - tulekahju avastajaks on inimene;
- teavitab inimene oma hääle ja käsiteadustist ATS- i töölerakendamise abil – tulekahju avastajaks on inimene.
- teavitab inimene, kasutades selleks telefoni, raadiosaatjat, tekstiedastussüsteemi vms. – tulekahju avastajaks on inimene.
- SMS asutuse töötajatele (nõ grupisõnumite põhimõttel) – saab teavitada asutuse personali
- Teade personali piiparitele – saab teavitada asutuse personali
- Info mobiiltelefoni kõne kaudu – saab teavitada asutuse personali
- Info raadiosaatjate kaudu – saab teavitada asutuse personali
- Info arvutiekraanidele (tänapäeval võivad inimesed tihti olla arvutites, klapid peas ja kuulata valju muusikat – seepärast on arvutiekraan hea alternatiiv teate edastamiseks) – saab teavitada asutuse personali

Näide:

Tulekahjust teavitamine

- Teavita hoone kasutajaid tulekahjust kohe, kui selle avastad. Kasuta selleks seinal asuvaid käsiteadusteid ja oma häält.



- Saades info tulekahjust või selle ohust kelleltki teiselt, dubleeri ohuteadet oma häälega või kasuta käsiteadustit, kui häirekellad veel ei tööta.
- Juhul kui saad teavitamiseks kasutada vaid oma häält, teavita esmalt neid kes asuvad tulekolde vahetus läheduses, selle kõrval või peal ning seejärel ülejäänud inimesi.
- Häirekellade mitterakendumisel või hääle kasutamise võimatuse korral, kasuta mobiiltelefoni või muid alternatiivseid teavitamisvahendeid.

2.2 Häirekeskuse teavitamine numbril 112

Häirekeskus saab tulekahjuteate automaatselt, kui asutuse ATS- il on vastav häireedastussüsteem. Selle süsteemi olemasolu tähendab ühtlasi seda, et käsiteadustist häire rakendamine ja häire automaatne rakendumine on häirekeskuses eristatavad. Käsiteadusti vajutamisel, mis tähendab tulekahju avastamist inimese poolt, reageerib päästemeeskond häirekeskuse korraldusel kohe.

Tulekahju avastaja peab üldjuhul häirekeskust telefoni teel teavitama olenemata asjaolust, et teade automaatselt 112- te ühendub.

Evakuatsioonijuht, saades tulekahju kohta kinnituse, peab veenduma, et häirekeskust on teavitatud.

NB! Hädabinumbrile saab mobiiltelefoniga helistada ka siis, kui teil ei ole kaardil kõneaega või kui telefonis puudub SIM-kaart.

HÄDAABINUMBRIL 112 helistades:

- räägi, mis on juhtunud, mis põleb, kui suures ulatuses;
- teata õnnetuskoha täpne aadress;
- ütle, kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;
- vasta küsimustele rahulikult;
- järgi päästekorraldajalt saadud juhiseid;
- teata oma nimi;
- ära katkesta kõnet ilma loata.

Ära lülita telefoni välja pärast teate edastamist – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada. Kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse. Näiteks: esimese kõne ajal oli teada, et kõik on majast väljas, kuid siis selgub, et keegi on ikkagi sisse jäänud.

MEELESPEA

• Kas Sinu töökohas on häire kõikjal kuuldav ?
• Kas häire on igal ajal kuuldav ja arusaadav ?
• Kas tead, kus asub ATS keskseade ?
• Kas oskad ATS- i keskseadet kasutada ?
• Kas tead, kus asuvad ATS- i käsiteadustid?
• Kas tead oma ülesandeid tulekahjuhäire rakendumisel ?

PEA MEELES!

NB! Häirekeskusesse tulekahjust teavitamine on igaühe kohustus!

112-te saab helistada:

- Suunakoodi valimata (välja arvatud nõ majasisene kood, et majast välja helistada – näiteks 0 112 või 9 112, sõltuvalt asutuse süsteemist)
- SIM kaardita (halva levi olukorras on see hea lahendus, kuna telefon otsib sellisel juhul ise tugevaima võrgu mistahes operaatorilt)
- Operaatoripoolse väljahelistamise piiranguga

2.3 Evakuatsioon

Evakuatsioon on kasutajate sunnitud väljumine ehitist või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.

Inimeste ohutuse tagamiseks on paljudes haiglates ja hoolekandeesutustes kasutatud erinevaid ehitustehnilisi lahendusi, mis tulekahju tekkimisel:

- võimaldavad tulekahju varases faasis avastada ja sellest hoonest viibijaid teavitada – kogu hoonel on automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem (ATS);
- tagavad teatud ajaks inimestele tule- ja suitsuvaba tsooni hoonest väljumiseks – tuletõkkesektsioonid;
- suunavad Sind mööda evakuatsiooniteed väljapääsuni ja tagavad evakuatsioonitee valgustatuse vähemalt ühe tunni vältel – turvavalgustus, mis on sõltumatu elektritoitega;
- kaitsevad hoonesse või ruumi „lõksu“ jäänud inimest aja vältel, mis on teda ümbritseva tuletõkkesektsiooni või ehituskonstruksiooni minimaalselt nõutav tulepüsivuse aeg.

Kõigi eeltoodud võimaluste nutikas kasutamine on eelduseks tulekahju korral evakueerumiseks.

Seega Sina, hea töötaja:

- ära suhtu ATS häiresse, kui ühest paljudest valehäiretest, vaid asu tegutsema „Tulekahju korral tegutsemise plaanile“ vastavalt;
- tee endale selgeks ATS- i kasutusvõimalused, et saaksid kahjutule avastamisel, kui ATS pole veel automaatselt rakendunud, ise häirekellad tööle panna;
- kui avastad, et tuletõkkehüpsiga EI30 või EI60 uks on tavaolukorras avatud asendis, sulge see ja vaata, kas selle sulgemisseade on töökorras. Teavita asutuse juhtkonda juhul kui ukse lahtioleku põhjust ise tuvastada ei suuda !
- kontrolli aeg- ajalt üle kõik Sinu töökoha korruse või korpuse **evakuatsioonipääsude** ukSED, samuti **trepikodade** välisuksed ja veendu, et need oleksid kiirelt ning lihtsalt avatavad;
- ära aseta evakueerumiseks kasutatavatele teedele esemeid ja materjale, kuna need takistavad õnnetuse korral inimeste kiiret ja ohutut evakueerumist. Kontrolli, et seda nõuet järgivad ka teised hoone kasutajad.

Tule ja suitsu levimise kiirusest sõltub, kui palju aega on evakuatsiooniks. Seega töötajate oskus tulekahju korral tegutseda võib olla inimeste hinnaga.

Erinevalt teistest asutustest, ongi haiglate ja hoolekandeesutuste põhiküsimus selles, kuidas tagada evakuatsiooniks piisav aeg, kui suurel osal klientidest/patsientidest enesepäästevõimekus puudub või on see piiratud ning samas pole ehituslike meetmetega takistatud tulekahju levimine. Samuti parandab evakueerimist teatud klientide ja patsientide isoleerimise vajadus igapäevaselt või poolelilolevad protseduurid, pikad evakuatsiooniteed ja töötajate nappus. Üha rohkem saab seejuures määravaks tulekahju varane avastamine ja evakuatsiooni algus.

2.4 Evakuatsiooni algus

Evakuatsioon algab üldjuhul tulekahjuteate saamisest, milleks võib olla:

- Häirekellade helin, vaikne alarm või automaatne tekst läbi helisüsteemi. On kokku lepitud, et evakueerutakse esimese või teise häire peale.
- Häirekellade helin ja kellegi füüsiline teavitus. On kokku lepitud, et evakuatsioon algab teise häire peale, kuid tulekahju avastaja rakendab käsiteadustist häirekellad tööle ja teist häiret ei järgne.
- Kellegi füüsiline teavitus. Tulekahju avastajal puudub ATS häire käivitamise võimalus.

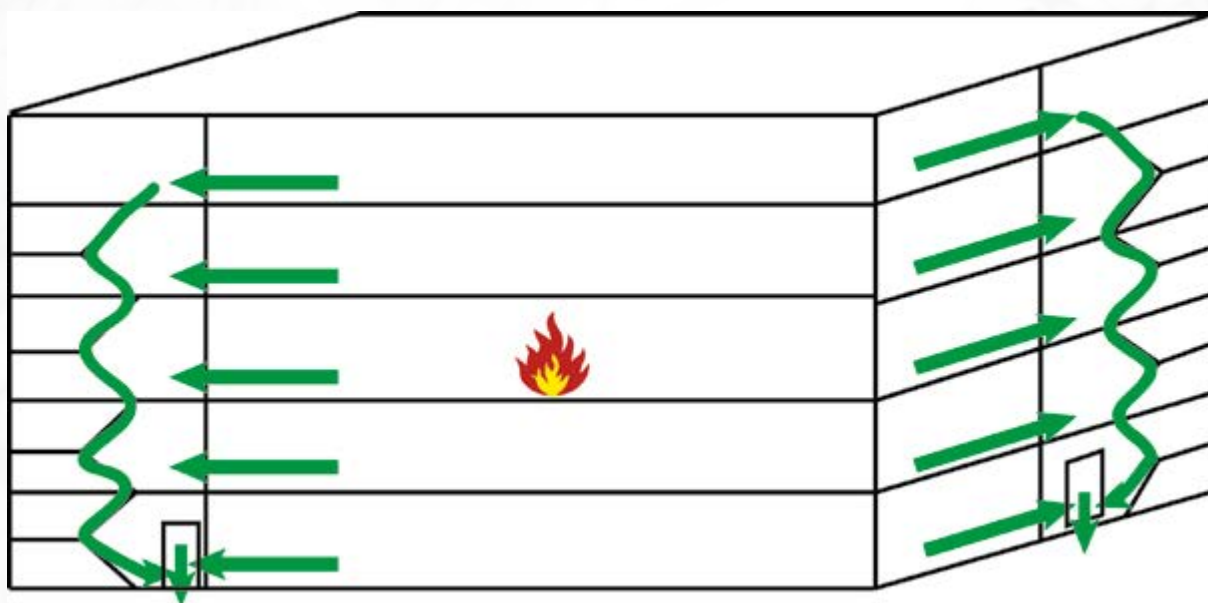
Haiglate erinevates osakondades ja hooldekodudes määrab seal olevate patsientide /klientide tervislik seisund selle, milline saab olema evakueerimise kord – kas, millal ja kuhu evakueeritakse. Operatsiooni-, intensiivravi-, nakkushaiguste- ja psühhiaatriaosakonnas ravil oleva patsiendi jaoks ei pruugi ATS häire tähendada kohest ohutusse alasse pääsemist, kuna evakueerimine võib kujutada ohtu tema enda ja teiste inimeste elule ja tervisele. Seega annab käsu või loa patsientide evakueerimiseks evakuatsioonijuht, kelleks võib erinevates asutustes, korpustes või osakondades olla määratud erineval ametikohal olev töötaja. Haigla intensiivraviosakonnas võib selleks olla näiteks valvearst, üldosakonnas aga hooldusõde.

Paljudes hooldekodudes on öisel ajal tööl vaid üks töötaja, mistõttu peab ta tegelema klientide teavitamise, evakueerimise, tulekahju kustutamise ja teiste tegevustega ainuisikuliselt, olles seejuures nii evakuatsioonijuht kui kliente päästev töötaja.

2.5 Evakuatsiooni põhimõtted

Selleks, et tulekahju või selle ohu korral evakueeruda ja korraldada klientide/patsientide evakuatsiooni, peab iga töötaja teadma asutuses kehtivat evakuatsiooni korda ja strateegiat. Strateegia põhineb hoone keerukuse, tulekahju avastamise, leviku tõkestamise ja kustutamise võimaluste, samuti patsientide/klientide hulga ning nende tervisliku seisundi põhjalikul analüüsil.

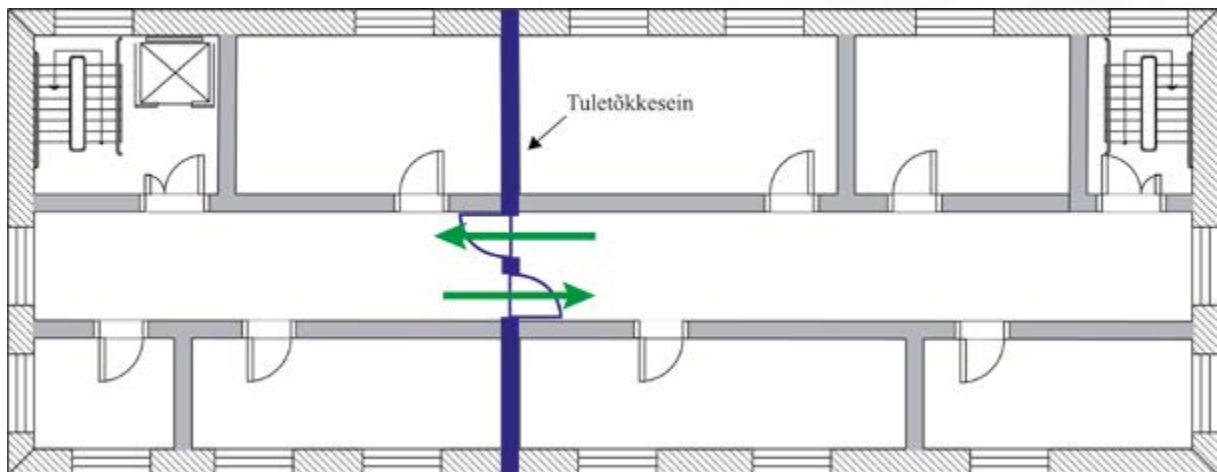
Üheastmeline evakuatsioon ehk kõigi inimeste väljumine hoonest on mõeldav vaid väiksemates haiglates ja hoolekandeesutustes, kus viibivad heas kehalises ja vaimses seisukorras kliendid/patsiendid. See tähendab ühtlasi seda, et nende tervise halvenedes peab asutus oma strateegia üle vaatama ja vajadusel muudatusi tegema.



Joonis 1. Üheastmeline evakuatsioon

Progressiivse ehk etapilise evakuatsiooni korral evakueeritakse vahetus ohualas olevad inimesed ohutusse alasse:

- Päästetakse põlevast ruumist
- Viiakse ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse sektsiooni samal korrusel – horisontaalne evakuatsioon
- Viiakse või suunatakse inimesed ära ohustatud korruselt - vertikaalne evakuatsioon
- Evakueeritakse ohustatud korpusest
- Evakueeritakse kogu hoonest



Joonis 2. Horisontaalne evakuatsioon

Edasilükatud evakuatsioon ehk ruumidesse jäämine on võimalik vaid juhul, kui klientide/patsientide ohutus neis on tagatud. See tähendab, et ehituslike meetmetega on tule ja suitsu levimine takistatud, on loodud tingimused ja võetud tarvitusele meetmed tulekahju kiireks kustutamiseks ning suitsu eemaldamiseks. Ruumidesse jäämine võiks kõige enam sobidagi sinna, kus on kliente või patsiente, kelle evakueerimine võib nende enda ja teiste tervisele ja elule ohtu kujutada.

Evakueerumise meelepea:

- säilita rahu ja enesevalitsus;
- võta kaasa ainult äärmiselt vajalik;
- väljudes ustest veendu, et see oleks ohutu – enne ukse avamist katsu käe seljaga ust, alustades altpoolt ja liikudes üles. Kui ukse alumise ja ülemise osa temperatuurid erinevad, võib tulekahju olla juba ukse taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi ja temperatuuri eest;
- sule enda järel ukse ja aknad takistamaks õhu juurdevoolu;
- suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seinääri;
- treppidel liigu ettevaatlikult, ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal tekib tavaliselt ummik;
- juhindu evakuatsioonimärkidest, need suunavad sind välja;
- hoonest väljudes mine kogunemiskohta.

Kui evakueeruda ei õnnestu:

- mine lähimasse ohutusse, tulekahjust haaramata ruumi;
- tihenda avad niisutatud riidesemetega/tekstiiliga;
- helista võimalusel mobiiltelefoniga 112 ja anna teada, et oled hoonesse lõksu jäänud;
- anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike vahenditega (lehvita aknalt, karju).

2.6 Eripärad klientide/patsientide evakueerimisel

Hooldusalused võivad oma liikuvuselt ja ka ümbritsevast arusaamiselt olla erinevatel tasemetel. Vaimsete häirete või vaimupuudega patsiendid võivad tulekahju korral toimuvast häiritud olla ning käituda seega ettearvamatult. Eeltoodut arvestades peab tagama nende pideva järelevalve pärast ohualast evakueerimist ja/või paigutamist hoonesse või ruumi, millest neil iseseisvalt pole võimalik lahkuda. Mõned patsiendid võivad olla voodihoolitusel või vajada ellujäämiseks meditsiinilist varustust. Paljudel juhtudel sõltub patsientide evakuatsioon personali arvust ja tegutsemisest.

Kliendid ja patsiendid, kes vajavad liikumiseks kõrvalist abi, evakueeritakse töötajate poolt ratastel vooditega, päästelohistitega, evakuatsioonitoolidega või muude kandmist või lohistamist hõlbustavate abivahenditega. Arvestama peab, et patsientide seisund ja seega nende evakueerimiseks vajalikud tegevused võivad lühikese ajaga muutuda.

Patsientide/klientide evakueerimise operatsiooni-, intensiivravi-, nakkushaiguste- ja psühhiaatriaosakonnast ning nende paigutamise teistesse osakondadesse või transpordi teise haiglasse otsustab evakuatsioonijuht.

2.7 Evakuatsiooni takistavad tegurid

Evakuatsiooni edukus sõltub mitmetest teguritest ja tihti nende koostööst. Mõnda neist on võimalik ette näha, kuid vahel võivad need avalduda sündmuse ajal.

- Ehituslikud - ebapiisav evakuatsioonipääsude arv, evakuatsiooniteed liiga pikad, -pääsud kitsad, halb teede tähistus ja valgustus, ebapiisav seksioneerimine (tule ja suitsu kiire levimine), varinguoht;
- Korralduslikud - takistused teel (ka ratastel voodid, millega on inimesi evakueeritud), ruumide/osakondade lukustus, vähene koolitus, vajakajäämine koostöös;
- Majanduslikud - personali vähe, ebapiisav evakuatsioonivahendite hulk;
- Tervislikud – patsiendi kõndimine aeglane või ei kõnni üldse, lamavad, protseduurid pooleli, meditsiiniseadmetega ühendatud (tilguti vms), liigutamine, tõstmine, lohistamine võib tervisele kahjuliku seisukorda järsult halvendada, dementsus, psüühikahäired, sõltuvushaiged, nägemis- ja/ või kuulmishäired;
- Käitumuslikud – paanika töötajates, patsientides, klientides, külastajates, klientide/patsientide alkoholi- või narkojoove, laste ettearvamatu käitumine.

2.8 Evakuatsioonijuhi ülesanded

Asutuses määratakse täpsem tegevus ja vastutus „Tulekahju korral tegutsemise plaanis,“ kuid üldjuhul korraldab esmast tegevust sündmuskohal olev töötaja (tulekahju avastaja). Evakuatsioonijuhi ülesanne sündmuskohale saabudes on esmalt tulekahju avastaja teavitamine juhtimise ülevõtmisest ning seejärel:

- Evakuatsiooni koordineerimine jagades töötajatele ülesandeid ja juhendades neid;
- Hapnikukraanide sulgemiseks loa või korralduse andmine;
- Evakueeritute ja evakueerunute kohta info kogumine;
- Kogunemiskohtade määramine;
- Sissepääsude juurde valve organiseerimine;
- Võimalusel abistamine evakueerimisel;
- Päästemeeskonna vastuvõtmine ja nende olukorrast teavitamine;
- Evakueerunud inimeste teistesse hoonetesse, osakondadesse või haiglatesse ümberpaigutamise korraldamine;
- Avalikkusega (meediaga) suhtlemine.

2.9 Kogunemiskoht ja käitumine kogunemiskohas

Hoonest, korpusest või osakonnast evakueerumisel peab olema koht, kuhu kliendid/patsiendid suunatakse või viiakse. Seal loendatakse nad üle ning edastatakse päästetöötajatele info pääsenute, tulekahju ulatuse jne. kohta. Kogunemiskohad on asutuses varem kokku lepitud, kuid päästetööde juht või evakuatsioonijuht võib seda muuta juhul, kui ilmneb oht pääsenutele, päästetööd on takistatud vms. Evakuatsioonijuht ei tohi kogunemiskohast enne päästetööde juhilt vastava loa saamist lahkuda.

2.10 Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

Päästetööde tõhusus sõltub hoone kasutajate ja päästjate omavahelisest koostööst. Seetõttu vajavad sündmuskohale saabunud päästjad infot, mis annaks võimalikult täpse ülevaate põlengu ulatusest, pääsenutest, jne.

On väga tähtis, et evakuatsioonijuht, kellel on tulekahju ulatuse, hoonest pääsenud inimeste või muud tulekahju kohta olulist infot, läheks esimesel võimalusel päästetööde juhi juurde, mitte päästetööde juht ei peaks otsima, kellelt ta vajalikku informatsiooni saab!

Päästetööde juhi tunneb tähtsusest ülevalt alla liikudes tavaliselt ära kollase (väga harvadel juhtudel ja suure sündmuse korral), oranži (operatiivkorrapidaja - tavaliselt), punase või sinise (rühmapealik/meeskonnavanem) kiivri järgi. Punase ja sinise kiivriga päästjad saavad alati suure päästeautoga. Päästetööde juht/operatiivkorrapidaja saabub sündmuskohale puna-valge maasturiga või kannab punast jopet (tavapäästjatel on tumesinised nn tuletõrjuja riided helkurribadega). Päästetööde juht on tavaliselt ka see, kes ise voolikutega ei toimetata, vaid annab korraldusi ja suhtleb raadiosaatjaga. Päästetööde juhil puudub tavaliselt seljas päästevarustus. Võib juhtuda, et esialgu saabub sündmuskohale ainult rühmapealik või meeskonnavanem – nemad juhivad sündmust seni, kuni saabub operatiivkorrapidaja, kes sündmuse üle võtab.

Päästetööde juhile teata:

- mis, kus ja kui suures ulatuses põleb;
- kas ja kui palju on hoonesse jäänud inimesi, milline on nende seisund ja kui suur on neid ähvardav oht;
- hoonesse jäänud inimeste oletatav asukoht;
- millist teed pidi jõuab kõige kiiremini hoonesse jäänud inimesteni ja tulekoldeni;
- kas tulekahjuga kaasneb muid ohtusid (põlevvedelike plahvatus vms);
- kus asub ATS keskseade.

Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjatelt vastava loa saamist, samuti peab ta täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi.

3. PRAKTILINE HARJUTUS

Koolitatava töökohal etteantud situatsiooni lahendamine – tulekahju korral tegutsemise plaani põhiselt selgitada oma tegevusi tulekahjuhäire korral.

4. KAASUS/ ÜLESANNE

4.1 Ülesanne 1

Hoolekandeaasutuses, mille töökorraldusest tulenevalt on öösiti tööl 2 hooldusõde ja 1 valveõde, rakendub kell 00:30 tööle ATS. Asutuses on kokku lepitud ja „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“ on kirjas, et evakuaatsioonijuht ohu korral on valveõde. Milline on nimetatud isiku edasised võimalikud tegevused, kui on teada järgmist:

1. Põleb lahtise leegiga hoolealuste Anka ja Jenka toa aknakardin;
2. Nimetatud isikud ning lisaks neile veel 7 on sellised, kes pole iseseisvalt võimalised evakueeruma;
3. Hoolealuseid on kokku 30;
4. Hoones on kõik toad ja 2 trepikoda eraldi tuletõkkeseksioonid;
5. Kutseline (riiklik) päästekomando jõuab sündmuskohale 10 minuti jooksul arvestades häire algusest;
6. ATS- i häire ühendub automaatselt häirekeskusesse.
7. ATS- i häire kontrollimine keskseadme tabloolt ja ohu ning selle asukoha tuvastamine on valveõde ülesanne.
8. Hoone on kahekorruseline, kuid kliendid, kes iseseisvalt ei liigu, on paigutatud esimesele korrusele.
9. Kokku on 1.korrusel 18 klienti.
10. Päästekomando saabub sündmuskohale ka siis kui tulekahju on suudetud oma jõududega kustutada ja sellest on häirekeskust teavitatud.

Ülesande lahendamisel lähtutakse koolitusmaterjalidest, asutuse „Tulekahju korral tegutsemise plaanist“ ja ülaltoodud situatsioonikirjeldusest.

Eesmärk: analüüsida, millised on klientide ohutuse tagamise ja/või evakueerimise võimalused ohustatud alast.

Võimalik lahenduskäik:

a) võimalik lahendus

- Häire korral kontrollib valveõde ATS- i keskseadmelt, millisest tsoonist (piirkonnast) häire tuleb, määrab ATS-i skemaatilise plaani järgi kindlaks täpse asukoha ja läheb häire põhjust kontrollima. Üldhäire väljalülitamise kontrollimise ajaks otsustab ülesande lahendaja vastavalt sellele, milline on tema töökohas teavitamise kord;
- Teavitab hooldusõdesid võimalikust ohust ja teatab selle asukoha;
- Võtnud häire asukohta kontrollima minnes või peale tulekahju avastamist seinalt tulekustuti, kustutab tulekahju;
- Evakueerib hooldusõde abiga hoolealused Anka ja Jenka ning sulgeb nende toa ukse;
- Helistab 112 ja teavitab häirekeskust häire põhjusest ja hoones valitsevast olukorrast ning klientide seisundist.
- Teavitab juhtkonda, kui teavitamise kord seda ette näeb.
- Võtab vastu päästemeeskonna ja teavitab neid:
 - ♦ mis, kus ja kui suures ulatuses põles;
 - ♦ kas ja kui palju on hoones inimesi, milline on nende seisund ja kas neid ähvardab oht;
 - ♦ hoonesse jäänud inimeste oletatav asukoht;
 - ♦ millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekolde asukohani;
 - ♦ kus asub ATS keskseade.

b) võimalik lahendus

- Häire korral kontrollib valveõde ATS- i keskseadmelt, millisest tsoonist (piirkonnast) häire tuleb, määrab ATS-i skemaatilise plaani järgi kindlaks täpse asukoha ja läheb häire põhjust kontrollima. *Üldhäire väljalülitamise kontrollimise ajaks otsustab töötaja vastavalt sellele, milline on tema töökohas teavitamise kord;*
- Teavitab hooldusõdesid võimalikust ohust ja teatab selle asukoha;
- Avastanud tulekahju, proovib esmaste tulekustutusvahenditega seda kustutada, kuid nähes, et see ei õnnestu, üritab hoolealuseid päästa. Kaasab nendesse tegevustesse hooldusõde;
- Sulgeb toast lahkudes toa ukse sõltumata sellest kas hoolealused päästa õnnestus või mitte;
- Teavitab kõiki kliente tuleohust ja annab hooldusõdedele korralduse klientide evakueerimiseks, enda järel uste sulgemiseks ning kogunemiskohta minemiseks;
- Määrab evakuaatsiooni strateegia ja vajadusel muudab seda;
- Helistab 112 ja veendub, et häire on automaatselt häirekeskusele edastatud ning annab ülevaate olukorrast;
- Abistab võimalusel inimeste evakueerimisel;
- Võtab vastu päästemeeskonna ja teavitab neid:
 - ♦ mis, kus ja kui suures ulatuses põleb;
 - ♦ kas ja kui palju on hoones inimesi, milline on nende seisund ja kas neid ähvardab oht;
 - ♦ hoonesse jäänud inimeste asukoht;
 - ♦ millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekolde asukohani ja inimesteni;
 - ♦ kus asub ATS keskseade.
- Annab päästetööde juhile hoone korruste plaanid;
- *Teavitab juhtkonda, kui teavitamise kord seda ette näeb.*

4.2 Ülesanne 2

Nimeta erinevaid tegureid, millest sõltub evakuaatsiooni aeg. Analüüsi, millised nendest võivad esinevada Sinu töökohas ning võivad põhjustada edasilükatud evakuaatsiooni.

Ülesande lahendamisel kasutatakse koolitusmaterjale ja lähtutakse asutuse või osakonna töökorraldusest ja klientide/patsientide eripärast.

Vastus

- Ehituslikud – ebapiisav evakuaatsioonipääsude arv, evakuaatsiooniteed liiga pikad, -pääsud kitsad, halb teede tähistus ja valgustatus, tulekahju levimine pole takistatud, varinguoht;
- Korralduslikud - takistused teel (ka ratastel voodid, millega on inimesi evakueeritud), ruumide/ osakondade lukustatus, vähene koolitus, vajakajäämine koostöös, uksi hoitakse lahti;
- Majanduslikud - personali vähe, ebapiisav evakuaatsioonivahendite hulk;
- Tervislikud – patsiendi kõndimine aeglane või ei kõnni üldse, lamavad, protseduurid pooleli, meditsiiniseadmetega ühendatud (tilguti vms), liigutamine, tõstmine, lohistamine võib tervislikku seisukorda järsult halvendada, dementsus, psüühikahäired, sõltuvushaiged, nägemis- ja/või kuulmishäired;
- Käitumuslikud – paanika töötajates, patsientides, klientides, külastajates, klientide/ patsientide alkoholi- või narkojoove, laste ettearvamatu käitumine.

HOOLDEKODU I KORRUS



HOOLDEKODU II KORRUS



4.3 Ülesanne 3

Joonistel on kahekorruselise hooldekodu põhiplaanid.

Olukorra kirjeldus

Hoones on 38 voodikohta, millest 31 on täidetud järgmiselt: 1.korrusel 13 klienti/patsienti, kellest 5 kõnnivad ilma kõrvalist abi vajamata, ülejäänud on lamavad; 2. korrusel 18 klienti/patsienti, kes on heas füüsilises vormis, kuid kohati võib neil ümbritsevast arusaamine olla raskendatud ja esineda psüühikahäireid. Hoones on lisaks Sinule 2 töötajat.

Kirjelda, millise evakuatsioonistrateegia tuleohu korral valid, mis valitud strateegiat iseloomustab ja millest valikul lähtud.

Ülesande lahendamisel kasutatakse koolitusmaterjale.

Võimalik lahendus

Valitakse etapiline või edasilükatud evakuatsioon. Kui inimeste tervislik seisund võimaldab ja tulekahju levik on takistatud, evakueeritakse vahetus ohualas olevad inimesed ohutusse alasse:

- Päästetakse põlevast ruumist;
- Viiakse või suunatakse ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse sektsiooni samal korrusel – horisontaalne evakuatsioon;
- Viiakse või suunatakse inimesed ära ohustatud korruselt - vertikaalne evakuatsioon;
- Evakueeritakse kogu hoonest.

Edasilükatud evakuatsiooni ehk ruumidesse jäämist kasutatakse ennekõike 2.korruse klientide puhul, kuna evakueerimine võib nende enda ja teiste tervisele ja elule ohtu kujutada. Tagatud peab olema inimeste ohutus ruumidesse jäämisel.

4.4 Ülesanne 4

Vasta koolitusmaterjalide põhjal alljärgnevatele küsimustele:

1. Mida on tarvis tulekahju toimumiseks?
2. Millest sõltub põlemise teke?
3. Mida peab tuleohu ennetamiseks tegema ?

Vastused:

Süüteallikas+ põlevmaterjal+ hapnik

Süüteallika olemasolust

Potentsiaalsed süüteallikad põlevmaterjalidest eraldama.

KOKKUVÕTE

Käesolevas õppematerjalis anti lühike ja põhimõtteline ülevaade töötaja käitumistest seoses tulekahju ennetamisega enda objektil kui ka ohuolukorras käitumiseks.

On siiski oluline silmas pidada, et tegelikud ja konkreetsed tegutsemisjuhised peavad olema kirjeldatud iga haigla ja hooldekodu tulekahju korral tegutsemise plaanis. Vähe sellest, neid tegevusi tuleb järjepidevalt harjutada, sest vaid nii on lootust, et teadmised kinnistuvad praktilise väljaõppe käigus.

Materjali koostajad loodavad, et koos käesoleva materjaliga, praktilise väljaõppe juhendmaterjaliga, asutuse tulekahju korral tegutsemise plaaniga ning teiste koolitusmaterjalidega on töötajal võimalik saada küllalt põhjalik ülevaade ohutust käitumisest ja ohuolukorras tegutsemisest.

KASUTATUD ALLIKAD

1. Karmel Tall, E-kursuse "Kriisipsühholoogia (P2AV.TK.475)" materjalid, Tartu Ülikool, 2012
2. Mart Murdvee. Toimetulek õnnetuste, kannatanute ja iseendaga. 21.10.2008

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn

Tel: +372 628 2000

rescue@rescue.ee

www.rescue.ee